



Rencontre avec Laurent Beziat, représentant du personnel des ambulanciers internes du CHU de Toulouse, et Isabelle Prono, aide-soignante, élue au CSE (Comité social et économique) et à la Formation spécialisée pour le syndicat SUD.

Entretien réalisé le 31 juillet 2026 au CHU Purpan.

1) Présentation, contexte et naissance du mouvement de grève

Laurent Beziat :

Je m'appelle Laurent Beziat. Je suis représentant du personnel des ambulanciers internes du CHU de Toulouse.

Vous expliquiez que vous étiez en mouvement de grève depuis le 11 mai. Pourquoi ?

Laurent Beziat :

Je vais vous donner le contexte. Il y a eu pas mal de dérives. Aujourd'hui, on nous demande d'effectuer de plus en plus de transports qui ne figurent pas dans notre fiche de poste, qui ne font pas partie de notre formation ni de notre diplôme.

Au départ, nous avons accepté de les faire parce qu'il fallait bien assurer le service. Puis on s'est rendu compte qu'au sein d'autres CHU, ces nouvelles missions avaient été reconnues et qu'elles donnaient lieu à une revalorisation interne. Nous avons demandé la même chose, à l'amiable. Mais

rien n'y a fait. Nous avons donc été obligés de lancer ce mouvement de grève pour obtenir une reconnaissance.

Comment ce mouvement s'est-il concrétisé ?

Laurent Beziat :

Nous étions 70 % du personnel en grève. Les autres étaient principalement des contractuels. Ils ne se sont pas permis de faire grève, mais ils soutiennent complètement le mouvement. Nous sommes une soixantaine d'ambulanciers répartis sur l'ensemble des sites du CHU de Toulouse. À noter qu'aucun ambulancier de notre équipe n'est syndiqué. En revanche, les syndicats CGT et SUD nous soutiennent.

Quelles ont été les premières propositions de la direction ?

Laurent Beziat :

La direction des ressources humaines nous a proposé de revoir notre fiche de poste et de mettre en place quelques petites formations.

Pour nous, c'était surtout une manière de noyer le poisson. Nous, ce que nous demandions avant tout, c'était un cadre sécuritaire, aussi bien pour les patients que pour les personnels. Aujourd'hui, nous réalisons des transports de corps, des transports pénitentiaires... Ce sont des missions dangereuses. Pourtant, il n'existe aucun protocole clairement défini. Par exemple, si vous organisez un transport entre Purpan et Rangueil et que votre ambulance tombe en panne au milieu du trajet, personne ne sait réellement quelle procédure appliquer.

Si j'appelle le SAMU, c'est vous qui intervenez ?

Laurent Beziat :

Non. Nous nous occupons exclusivement du transport hospitalier, c'est-à-dire des liaisons entre les différents établissements publics.

Pour une urgence vitale, c'est soit le SAMU, soit les pompiers, soit une ambulance privée qui intervient.

Aujourd'hui, nous assurons les transports internes du CHU, mais une partie de nos missions est également confiée au privé pour nous soulager, parce que nous avons énormément de transports à effectuer.

Les transports pénitentiaires

Vous évoquiez les transports pénitentiaires. En quoi consistent-ils exactement ?

Laurent Beziat :

À l'hôpital Rangueil, il existe une unité hospitalière pénitentiaire. Nous assurons tous les transports des détenus entre les différents hôpitaux lorsqu'ils doivent se rendre en consultation.

Il faut savoir que, faute de personnel dans cette unité, il y a très peu d'escortes pénitentiaires disponibles. Les détenus restent donc hospitalisés plus longtemps que prévu.

Pour eux, c'est extrêmement difficile, car ils n'ont pas de promenade, très peu de contacts avec leurs familles et vivent dans un environnement particulièrement fermé.

Psychologiquement, cela peut créer beaucoup de tension. Pour nous aussi, cela représente un risque important. Nous assurons également des transports pour le GIPN. Dans ces cas-là, nous sommes escortés par des agents cagoulés et armés de mitraillettes. Il peut s'agir de personnes fichées S ou de membres du grand banditisme. Nous ne savons jamais qui nous transportons avant le départ. Lors de ces missions, deux véhicules d'escorte ouvrent et ferment le convoi, tandis qu'un agent pénitentiaire prend place dans notre ambulance. Il a fallu nous battre pour obtenir des gilets de protection. Encore aujourd'hui, il ne s'agit pas de véritables gilets pare-balles, mais seulement de gilets pare-lames, qui offrent une protection inférieure.

En nous renseignant, nous avons découvert que nos collègues du CHU de Lyon bénéficiaient de formations spécifiques avec les agents pénitentiaires, de formations à la conduite dans ce contexte ainsi que d'une dotation en véritables gilets pare-balles adaptés aux missions.

Lors des transports de détenus, vous êtes donc accompagnés par l'administration pénitentiaire ?

Laurent Beziat :

Oui. Un véhicule pénitentiaire nous suit derrière l'ambulance et un agent pénitentiaire est présent avec nous dans le véhicule.

Ces missions figurent-elles dans votre fiche de poste ?

Laurent Beziat :

Même pas.

Notre fiche de poste prévoit essentiellement :

- le brancardage des patients ;
- la gestion des documents administratifs ;
- la vérification du matériel ;
- le transport des patients d'un hôpital à un autre.

C'est tout.

Depuis combien de temps vous demande-t-on d'effectuer toutes ces autres missions ?

Laurent Beziat :

Pour les transports pénitentiaires, c'est cyclique. Lorsque des sociétés privées acceptent les marchés publics, elles assurent ces transports. Mais elles rencontrent souvent des difficultés de disponibilité ou de rentabilité. Le marché tombe alors à l'eau... et cela revient chez nous. À chaque fois, nous devons improviser. On nous demande de prendre ces missions au pied levé, sans avoir réellement le choix. Lors des négociations avec la direction, nous avons expliqué que cela nous posait problème. On nous a répondu que ces transports allaient nous être retirés. Dans les faits, ce n'est pas vrai. D'autant plus qu'ils n'ont toujours pas trouvé de prestataire capable de nous remplacer.

2) La rémunération, la reconnaissance du métier et les revendications

Je suppose que vous êtes soumis à une grille salariale ?

Laurent Beziat :

Oui. Nous dépendons de la grille salariale de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Concrètement, c'est la grille la plus basse. Selon les échelons, on est quasiment au niveau du SMIC. Lors du Ségur de la santé, les aides-soignants sont passés en catégorie B parce qu'il a été reconnu qu'ils étaient personnels soignants. Nous, notre formation ne dépasse pas les 1 000 heures. C'est ce qui a servi d'argument pour nous maintenir en catégorie C.

Vous n'êtes donc pas considérés comme des soignants ?

Laurent Beziat :

Pourtant, un décret est paru en 2021 reconnaissant les ambulanciers comme des soignants. À partir de ce moment-là, notre service aurait dû être encadré par un directeur des soins. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Nous avons une cadre de proximité, qui est soignante, depuis deux ans. Elle va partir prochainement et nous ne savons toujours pas qui la remplacera. Avant elle, nous avons connu des cadres qui venaient du BTP ou même de la grande distribution, sans aucun lien avec le soin. À chaque changement, il faut tout reprendre à zéro : expliquer notre métier, nos contraintes, nos responsabilités...

Quelles étaient vos revendications au départ de la grève ?

Laurent Beziat :

Au départ, nous demandions une compensation financière pour les risques que nous prenons et pour toutes les missions qui ne figurent pas dans notre fiche de poste. Nous demandions notamment la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), puisqu'elle est justement prévue lorsqu'un agent exerce des fonctions supplémentaires. Tout cela nous a été refusé. La raison invoquée est simple : statutairement, nous appartenons à la filière logistique. Or, dans cette filière, ces primes n'existent pas. Si nous appartenions à la filière Urgences ou à la filière Soins, nous pourrions y prétendre. Pourtant, dans plusieurs CHU, les directions ont trouvé des solutions. Nous sommes le quatrième CHU de France et, ici, rien ne bouge.

Vous avez tout de même eu des échanges avec la direction ?

Laurent Beziat :

Oui. Lorsque nous avons rencontré le directeur, il n'a pas été insensible à l'idée de nous faire changer de filière, notamment pour intégrer la filière Urgences et accompagner le SAMU. Mais depuis cette réunion, c'est le statu quo. Nous n'avons plus aucune nouvelle. Et même, aujourd'hui, ils semblent revenir sur ce qui avait été évoqué. Nous avons également sollicité le professeur responsable du SAMU afin de lui expliquer que nous souhaiterions rejoindre sa filière. Pour lui aussi, ce serait logique. Cela représenterait davantage de personnel disponible pour les plans catastrophes et les situations d'urgence. Nous pourrions intervenir en renfort. Tout cela nous paraît cohérent. Pour le moment, nous n'avons reçu aucune réponse.

Et tout cela sans aucune compensation financière ?

Laurent Beziat :

Exactement.

Comment expliquez-vous une rémunération aussi faible ?

Laurent Beziat :

Parce que les contrats de catégorie C sont construits comme ça. Aujourd'hui, nous sommes rémunérés au même niveau qu'un agent d'entretien du CHU.

Notre mouvement porte donc sur deux revendications principales : l'IFR (Indemnité forfaitaire de risque) et la NBI. Mais, au-delà de notre situation, il existe déjà un mouvement national. Partout en France, les ambulanciers hospitaliers demandent le passage en catégorie B. C'est pour cela que nous essayons de porter ce dossier au niveau national.

Nous souhaitons saisir la ministre de la Santé afin de faire évoluer un métier qui n'a pratiquement pas changé depuis des années.

Où en est votre mouvement aujourd'hui ?

Laurent Beziat :

Nous sommes le 31 juillet. Nous reprendrons probablement le mouvement en septembre. Les dates ne sont pas encore arrêtées. Nous prévoyons également de monter à Paris en octobre avec plusieurs CHU afin d'interpeller directement le ministère de la Santé. Nous avons déjà rencontré des députés de La France insoumise et du Parti socialiste. Ils ont engagé une première saisine. Nous souhaitons également vous rencontrer afin de regrouper l'ensemble des démarches. Ils doivent envoyer leurs courriers pendant l'été afin d'alerter la ministre. De mon côté, j'ai également rédigé un courrier à la ministre pour dénoncer ce manque d'équité entre les différents CHU.

Vous avez également cherché un soutien syndical plus large ?

Laurent Beziat :

Oui. Nous aurions souhaité créer une intersyndicale au sein du CHU. Malheureusement, ici, les organisations syndicales ne parviennent pas à s'entendre entre elles.

Les sanctions disciplinaires

Votre mouvement a pourtant entraîné des procédures disciplinaires ?

Laurent Beziat :

Oui. Aujourd'hui, dix ambulanciers sont convoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Ils risquent un blâme ou un avertissement. Cela fait suite à ce que la direction appelle un blocage des ambulances. En réalité, il ne s'agissait pas d'un blocage total, mais d'un filtrage. Au moment où nous parlons, les convocations se déroulent à l'Hôtel-Dieu. Ils n'ont rien fait de mal. Pourtant, un constat d'huissier a été réalisé.

La grille salariale expliquée par Isabelle Prono

Isabelle Prono :

En réalité, nous dépendons d'une grille salariale dans laquelle nous gravissons progressivement des échelons. Mais les augmentations restent dérisoires. Comme le point d'indice est gelé, notre salaire dépend finalement du bon vouloir des politiques publiques. Et on connaît le résultat... Les augmentations sont très faibles. On change d'échelon après un an, deux ans, trois ans d'ancienneté, et cela représente parfois une quinzaine d'euros supplémentaires. C'est particulièrement flagrant pour les catégories C. Ce sont elles qui subissent le plus durement le gel du point d'indice. Ce sont pourtant les personnels de première ligne.

« D'autres obtiennent des compensations... pas nous »

Laurent Beziat :

Nos cadres de proximité bénéficient d'un arrangement avec la direction. Ils exercent en faisant fonction et sept heures supplémentaires sont intégrées afin d'améliorer leur rémunération. Lors des négociations, nous avons demandé à bénéficier du même type de dispositif. Puisque les primes semblaient impossibles d'un point de vue statutaire, nous avons demandé que la direction regarde ce qui se faisait ailleurs. La réponse a été un refus catégorique.

Aujourd'hui, par exemple, une infirmière hygiéniste assure les fonctions de cadre de proximité. C'est une mission supplémentaire qui lui est reconnue. Nous, avec les transports pénitentiaires et les transports mortuaires, nous assurons aussi des missions supplémentaires. Mais elles, elles ne sont pas reconnues.

Prenons l'exemple de la morgue. Les agents qui y travaillent perçoivent cette prime. Pourtant, ils n'assurent pas toutes les missions prévues dans leur fiche de poste. Le transport des corps, c'est nous qui le faisons depuis le début. La direction répond que nous n'effectuons pas l'ensemble des

missions mortuaires puisque nous ne réalisons pas la mise en bière. Donc nous n'aurions droit à rien.

Ce que nous dénonçons, c'est le risque

Laurent Beziat :

Ce que nous dénonçons avant tout, ce sont les risques. Même si le risque est de 1 %, il n'est jamais de zéro. Lors d'un transport pénitentiaire, si quelque chose tourne mal, nous sommes directement exposés. Toutes ces missions représentent les coulisses de l'hôpital. Nous faisons fonctionner énormément de choses. Nous nous occupons de tout. Mais derrière, rien n'est reconnu.

3) Les formations, les risques du métier, les transports mortuaires et la vocation

« On apprend tout sur le tas »

Avez-vous reçu une formation pour toutes ces missions ?

Laurent Beziat :

Quand j'ai été embauché, je n'ai reçu aucune formation concernant les transports mortuaires. On apprend tout sur le tas, au fur et à mesure. La seule formation qui existe intervient au bout de trois ou quatre ans. C'est simplement une sensibilisation aux différents cultes religieux.

Pour le reste, on apprend en faisant.

« Ce que nous dénonçons, c'est le risque »

Laurent Beziat :

Ce que nous dénonçons avant tout, c'est l'exposition permanente aux risques. Même si le risque est faible, il n'est jamais nul. Lors d'un transport pénitentiaire, si la situation dégénère, nous sommes directement exposés. Toutes ces missions, ce sont les coulisses de l'hôpital. Nous faisons énormément de choses. Nous sommes partout. Mais derrière, rien n'est réellement reconnu.

Qu'est-ce qui vous a amené à devenir ambulancier ?

Laurent Beziat :

Au départ, c'est la facilité d'accès au métier. Il ne demande pas un très long cursus de formation. Mais une fois qu'on y entre, ça devient une vocation. C'est une passion. Le contact avec les patients est formidable. Pour rien au monde je ne changerais de métier. Ce que je veux, c'est simplement qu'il évolue et que l'on soit reconnu pour ce que l'on fait.

Isabelle Prono : « Les infirmiers ont connu la même situation »

Isabelle Prono :

Pour compléter ce que dit Laurent concernant les transferts des patients de l'UHSI (Unité hospitalière sécurisée interrégionales), il faut rappeler que, quelques années auparavant, les infirmiers avaient eux aussi tiré la sonnette d'alarme.

On leur demandait d'accompagner des transferts de patients considérés comme dangereux. Normalement, ces transferts entre une unité fermée et la prison doivent être assurés par l'administration pénitentiaire, avec un encadrement spécifique, des escortes armées et des procédures très précises. À un moment donné, les infirmiers ont refusé. Ils estimaient que ce n'était pas leur rôle. Pourquoi des infirmiers, sans protection particulière, devraient-ils assurer ces transferts alors que cette mission relève normalement de l'administration pénitentiaire ?

Les limites des sociétés privées

Laurent Beziat :

Le problème avec les sociétés privées, c'est que leur personnel ne connaît pas toujours les protocoles. Il arrive qu'ils se présentent sans pièce d'identité. Parfois, certains ont même un casier judiciaire. Nous, notre casier est vérifié. Eux, non. Il est déjà arrivé que certains soient refusés pour cette raison. Concernant les détenus, nous ne connaissons jamais leur identité. Elle est protégée. En revanche, les agents pénitentiaires disposent d'une fiche qui classe la dangerosité du détenu sur une échelle de 1 à 3. Mais cette évaluation peut évoluer pendant le transport. Le patient peut décompenser. Il peut perdre le contrôle.

Après ce type de missions, bénéficiez-vous d'un accompagnement psychologique ?

Laurent Beziat :

Non. Zéro. Nous avons déjà évoqué le droit de retrait. Il nous est refusé. Autrement dit, si nous refusons une mission parce que nous estimons qu'elle est dangereuse, nous risquons d'être sanctionnés, voire de recevoir un blâme.

Quand j'ai été recruté, personne ne m'a expliqué que je transporterai des corps. Personne ne m'a demandé si j'étais prêt à le faire. Mon premier transport mortuaire concernait un nouveau-né décédé à l'hôpital des enfants et c'est traumatisant. Et pourtant, il n'existe aucune cellule psychologique. Il y a bien la médecine du travail, mais cela ne répond pas à ce type de situation.

Des risques parfois méconnus

Laurent Beziat :

Prenons l'exemple de la médecine nucléaire. Il y a des risques liés à la radioactivité. Pourtant, nous ne recevons aucune formation spécifique en interne. Nous avons demandé des actions de prévention, des ateliers, de la sensibilisation. Nous n'avons jamais rien obtenu.

Une ambulancière enceinte est même entrée dans ce service alors que cela lui était strictement interdit. Elle ne le savait tout simplement pas. Ce sont des sujets tabous. Tout le monde les connaît, mais personne n'en parle. Et rien ne change.

L'absentéisme

Y a-t-il beaucoup d'arrêts maladie chez les ambulanciers ?

Laurent Beziat :

Avant la grève, il y avait très peu d'absentéisme. Depuis le début du mouvement, il a un peu augmenté. Mais malgré tout, il y a davantage de grévistes que d'agents en arrêt maladie.

Les procédures disciplinaires vues par Isabelle Prono

Isabelle Prono revient sur les dix ambulanciers convoqués devant le conseil de discipline.

Isabelle Prono :

J'espère sincèrement qu'il n'y aura aucune mise à pied. Ces procédures disciplinaires engagées contre les ambulanciers sont un scandale. Mais malheureusement, ce n'est pas nouveau.

La direction du CHU de Toulouse supporte très mal les mouvements de grève lorsqu'ils sont fortement suivis et qu'ils bénéficient d'une forte mobilisation. Je l'ai moi-même vécu avec les urgences. À l'époque, près de 80 % du personnel était en grève. À la fin du mouvement, des procédures disciplinaires ont été engagées contre de jeunes professionnels de santé qui venaient pourtant d'être recrutés, alors même que l'hôpital faisait face à une pénurie d'infirmiers. Ils ont reçu des lettres recommandées. Ils ont été convoqués. Certains ont écopé d'un blâme simplement parce qu'ils n'avaient pas répondu à des assignations délivrées par huissier.

Voilà comment la direction du CHU de Toulouse répond à un droit pourtant constitutionnel : le droit de grève.

À partir du moment où un mouvement est suivi, qu'il devient visible et qu'il bénéficie d'une couverture médiatique — et les ambulanciers ont énormément travaillé sur cet aspect — la direction cherche à intimider les grévistes pour empêcher toute reprise du mouvement. C'est exactement ce qui s'est passé aux urgences. Les collègues ont reçu des blâmes. Sur le papier, cela peut sembler anodin. Mais pour un professionnel de santé qui donne le meilleur de lui-même toute l'année, qui revient sur ses repos, accepte des modifications de planning, fait des heures supplémentaires et remplace ses collègues, recevoir un blâme, c'est un véritable message.

On lui dit finalement :

"Vous êtes un voyou. » C'est cela que l'on dit aux grévistes. Alors, qui sont les voyous dans cette histoire ? Selon moi, ce ne sont certainement pas les grévistes. C'est une méthode de la direction.

4) Les recours engagés, l'organisation du service et le soutien syndical

« Humainement, nous avons raison... mais juridiquement, tout est bloqué »

Avez-vous envisagé une action en justice ?

Laurent Beziat :

Au départ, nous avons envisagé d'engager une procédure juridique et de prendre contact avec une avocate. Mais, statutairement, tout est bloqué. Tant que nous restons dans cette filière, il est impossible de négocier les primes que nous demandons. Humainement, je suis convaincu que nous avons raison. Mais juridiquement, cela ne passe pas. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État. C'est à lui de faire évoluer les textes. Quand nous faisons remonter cette situation à la direction, elle nous répond que, tant que rien ne change au niveau national, elle ne fera rien localement.

Des courriers adressés aux élus

Laurent Beziat :

J'ai également contacté Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, ainsi que Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, afin d'obtenir leur soutien. La seule réponse obtenue est qu'il serait envisagé de nommer un directeur des soins ou un cadre de santé pour notre service. Mais, dans le même temps, lorsque nous consultons les offres d'emploi publiées par le CHU, nous constatons qu'ils recherchent simplement un cadre de proximité, sans exiger de compétences particulières dans le domaine des soins. Depuis notre mouvement de grève, nous avons même l'impression que la direction insiste davantage pour que nous continuions à assurer ces missions supplémentaires, toujours sans protocole. Notre cadre de proximité part en septembre. À ce jour, nous ne savons toujours pas qui va lui succéder.

Un ambulancier pourrait-il devenir cadre de proximité ?

Laurent Beziat :

Eh bien non. Pourtant, ce sont les ambulanciers qui connaissent le mieux le métier. Mais la direction refuse de faire évoluer les agents en interne. Si un ambulancier souhaite devenir cadre, elle préfère qu'il quitte le service pour exercer ailleurs. Nous ne pouvons pas évoluer au sein de notre propre équipe.

Le regard d'Isabelle Prono sur le métier d'ambulancier

Vous n'êtes pas ambulancière ?

Isabelle Prono :

Non. Je suis aide-soignante. Je travaille dans les soins et je côtoie les ambulanciers tous les jours. C'est en les accompagnant que j'ai découvert l'étendue de leurs missions. Ils assurent le lien entre les services. Ils transportent les patients. Ils sont présents partout : en pédiatrie, à la maternité, en gériatrie, en psychiatrie... En réalité, ils interviennent dans l'ensemble des services du CHU. Ils accomplissent un travail de dingue.

« Nous sommes finalement très peu nombreux »

Enfin, combien êtes-vous pour assurer toutes ces missions ?

Laurent Beziat :

La nuit, une seule équipe couvre tout le secteur toulousain. Une équipe, cela représente seulement deux ambulanciers. La nuit, nous assurons les urgences ainsi que les transports mortuaires. Depuis toujours, la direction refuse de créer une deuxième équipe.

En journée, nous sommes trente agents, soit quinze équipes, auxquelles s'ajoute un renfort assuré par des sociétés privées. À l'échelle de la métropole toulousaine, cela reste très peu. En moyenne, nous réalisons environ 500 transports.

Le soutien du syndicat SUD

Isabelle, vous êtes aujourd'hui en soutien du mouvement ?

Isabelle Prono :

Oui. Je suis représentante du personnel. Lorsque les ambulanciers sont venus nous alerter sur leur situation, il était évident que nous allions les soutenir. Mais il faut être clair : ils ont toujours décidé eux-mêmes de leurs actions. Franchement, je rêve d'une grève comme celle des ambulanciers.

Laurent Beziat :

C'était la première fois que nous faisons grève. Nous avons besoin des syndicats pour nous guider. Nous ne savions pas du tout comment cela fonctionnait.

Isabelle Prono :

Je ne sais même pas qui a guidé qui, finalement. Oui, il fallait déposer un préavis de grève. Nous nous en sommes chargés. Il fallait également sécuriser certains aspects réglementaires, notamment les assignations. Nous avons essayé de les protéger sur le plan juridique. Mais tout le reste, les actions, la préparation du mouvement, le travail de fond... Tout cela, ce sont les ambulanciers qui l'ont construit. Ils ont notamment réalisé un énorme travail de recherche, en particulier sur les chiffres.

« Les chiffres officiels ne reflètent pas notre activité »

Laurent Beziat :

Il existe un vrai flou concernant la traçabilité de notre activité. Les transports réalisés en urgence ne sont pas comptabilisés. Tous les transports que le SAMU nous délègue parce qu'il ne peut pas les effectuer ne figurent pas non plus dans les statistiques. Nous sommes donc obligés de tenir nos propres relevés. La direction s'appuie ensuite sur ses chiffres pour affirmer qu'il s'agit de missions occasionnelles, voire rares. Mais ce n'est pas la réalité. Chaque jour, ces missions viennent s'ajouter à notre activité. Nous sommes obligés de les comptabiliser nous-mêmes parce que ce travail n'est pas fait par la direction.

« Cette grève est avant tout celle des ambulanciers »

Isabelle Prono :

Sur ce dossier, ce sont vraiment les ambulanciers qui ont construit leur mouvement. Bien sûr, cette grève est aussi un peu la nôtre puisque nous les accompagnons. Mais c'est avant tout leur combat.

Un problème qui dépasse les seuls ambulanciers

Laurent Beziat :

En réalité, beaucoup de professions du CHU rencontrent les mêmes difficultés. Prenons les manipulateurs en imagerie. Ils ne perçoivent pas la prime Urgences alors qu'ils prennent pourtant en charge des patients en urgence. La direction considère qu'ils ne réalisent pas cette mission à 100 %. C'est le même raisonnement partout. Les primes ont été réduites ou supprimées. Il y a aussi la prime Soins critiques. Au départ, les collègues de chirurgie maxillo-faciale la percevaient intégralement. Puis, un jour, la direction leur a expliqué qu'ils n'étaient pas en soins critiques en permanence. Résultat : leur prime a été réduite de moitié.

5) Les procédures disciplinaires, les piquets de grève et les attentes des ambulanciers

« Depuis le 11 mai, ils ont surtout dépensé de l'argent en huissiers »

Comment la direction a-t-elle réagi au mouvement de grève ?

Laurent Beziat :

Depuis le 11 mai, la direction a dépensé énormément d'argent pour faire intervenir des huissiers. Chaque assignation coûte plus de 300 euros.

Isabelle Prono :

Les huissiers ont dressé des procès-verbaux à partir d'images où l'on ne voit finalement pas grand-chose. On y voit simplement des agents entrer dans leur service. Il n'y a pas d'infraction caractérisée. Les ambulanciers sont accompagnés par les organisations syndicales et nous verrons ensuite quelles décisions prendra la direction.

« Les renseignements généraux sont même venus »

Laurent Beziat :

Pendant nos piquets de grève, la direction a fait venir les Renseignements généraux. Comme si nous étions en train de brûler des palettes ou de commettre des dégradations. Comme si nous étions des

délinquants. Même les agents présents nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été envoyés.

Isabelle Prono : « Les dossiers sont extrêmement faibles »

Craignez-vous de lourdes sanctions disciplinaires ?

Isabelle Prono :

Par rapport aux procédures disciplinaires, nous sommes relativement rassurés. Au vu du peu d'éléments contenus dans les dossiers, je ne pense pas que cela aille très loin. Il pourrait y avoir des blâmes. Mais, à ce stade, les éléments sont très faibles.

Le garage des ambulances au cœur des accusations

Laurent Beziat :

Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous disposons d'un garage fermé où stationnent les ambulances. Avant le mouvement, la direction a déplacé les véhicules à l'extérieur du CHU afin d'éviter qu'ils soient bloqués. Par la suite, les dix ambulanciers aujourd'hui mis en cause ont simplement déplacé les ambulances. Certains les ont notamment remises à l'ombre, comme cela avait déjà été fait lors des fortes chaleurs. Le lendemain, il y a eu le filtrage. C'est à partir de là que la direction leur a reproché une prétendue intrusion dans le bâtiment. Elle a même laissé entendre qu'ils auraient dérobé les clés. Comme si nous étions des voleurs.

Isabelle Prono :

Les clés ont été retrouvées. Il n'y a donc aucun vol. Et surtout, il n'existe aucune preuve matérielle démontrant que ce sont eux. Oui, ils étaient présents. Mais ils étaient présents parce qu'ils participaient au piquet de grève organisé par les syndicats. Le piquet de grève se trouvait justement au garage des ambulances. Il est donc parfaitement normal qu'ils aient été sur place.

« Nous n'avons jamais bloqué totalement le service »

Laurent Beziat :

Si nous avions voulu bloquer complètement le service, aucune ambulance ne serait sortie du garage.

Or ce n'est pas ce qui s'est passé. Des missions ont continué à être assurées. Il y a eu quelques retards. Mais le service a continué de fonctionner.

« Ce que nous demandons, c'est d'être couverts »

Au fond, quelle est votre principale inquiétude ?

Laurent Beziat :

Ce que nous demandons, c'est simple. Si un problème survient pendant une mission, sommes-nous réellement couverts ? Dans le discours de la direction, la réponse est toujours oui. Mais, dans les faits, nous restons entièrement responsables de nos actes. Et si nous réalisons des gestes qui ne figurent pas dans nos missions ou dans notre fiche de poste, c'est nous qui sommes en faute. C'est cela qui nous inquiète.

Isabelle Prono : « Une répression injustifiée »

Isabelle Prono :

J'aimerais vraiment insister sur un point. La direction du CHU emploie aujourd'hui des méthodes répressives contre des agents qui exercent simplement un droit constitutionnel : le droit de grève.

Ces ambulanciers ne demandent qu'une chose : améliorer leurs conditions de travail et obtenir une rémunération à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Leurs salaires sont dérisoires. Pourtant, ils continuent d'assurer des missions toujours plus nombreuses et plus risquées. Les procédures disciplinaires engagées contre eux sont, selon moi, totalement injustifiées et profondément injustes.

Transcription de la vidéo

Laurent Beziat :

Bonjour.

Je m'appelle Laurent Beziat. Je suis ambulancier inter hospitalier au CHU de Toulouse. Nos missions consistent à assurer les transports inter hospitaliers pour le CHU. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une grève illimitée depuis le 11 mai, parce que nos missions deviennent de plus en plus compliquées, complexes et dangereuses. Nous assurons des transports de corps, des transports pénitentiaires, des transports psychiatriques... Toutes ces missions ne sont pas suffisamment cadrées. Il n'existe pas de protocoles précis. Notre métier n'a bénéficié d'aucune revalorisation. Notre fiche de poste est restée très limitée alors que nos missions, elles, se sont considérablement élargies. C'est pour toutes ces raisons que nous faisons grève. Nous nous sommes également rendu compte qu'il existait un manque d'équité entre les différents CHU. Dans certains établissements, ces missions sont reconnues. Dans d'autres, comme le nôtre, elles ne le sont pas. C'est pourquoi nous lançons un appel à un rassemblement collectif afin d'interpeller la ministre de la Santé. Notre direction nous répond qu'elle restera fermée tant qu'aucune décision nationale ne sera prise.

Nous Président, que changeriez-vous concrètement ?

Laurent Beziat :

Je souhaiterais une vision plus moderne de notre métier. Aujourd'hui, il existe deux corps d'ambulanciers au CHU : les ambulanciers du SAMU et les ambulanciers internes. Nous faisons pratiquement les mêmes missions. Pourtant, nous dépendons de deux filières différentes. Les ambulanciers du SAMU appartiennent à la filière Urgences. Nous appartenons à la filière Logistique. Eux bénéficient de formations adaptées, de primes et de moyens spécifiques. Nous, tout cela nous est refusé.

Vous évoquez également votre classement en catégorie C. Qu'est-ce que cela signifie ?

Laurent Beziat :

La catégorie C correspond à la grille salariale la plus basse du CHU. Pendant le Ségur de la santé, les aides-soignants sont passés en catégorie B parce qu'il a été reconnu qu'ils réalisaient plusieurs gestes médicaux. Aujourd'hui, nous estimons mériter la même reconnaissance. Le problème vient du nombre d'heures de formation exigé. Nous ne les atteignons pas. C'est pourquoi nous demandons une véritable mise à jour de notre métier. Nous souhaitons que la formation évolue afin d'atteindre le volume horaire nécessaire et d'obtenir la même reconnaissance. D'ailleurs, lorsqu'un ambulancier souhaite devenir aide-soignant, il ne lui manque qu'environ un mois de formation.

Vous évoquiez également un décret adopté en 2021 ?

Laurent Beziat :

Oui. Depuis ce décret, les ambulanciers sont officiellement considérés comme des soignants et non plus comme de simples transporteurs. Nous ne transportons pas des marchandises. Nous ne transportons pas des colis. Nous transportons des êtres humains. Nous souhaitons donc être pleinement reconnus comme des soignants. Cela implique de participer aux transmissions avec les infirmiers et les aides-soignants afin de disposer de toutes les informations nécessaires sur les patients que nous transportons. C'est une question de sécurité.

Qu'attendez-vous aujourd'hui des responsables politiques ?

Laurent Beziat :

Nous avons toujours répondu présents lors des grandes catastrophes et des grandes crises sanitaires. À chaque fois, on nous remercie. À chaque fois, on nous dit que notre travail est reconnu. Mais derrière ces discours, rien ne change. Aujourd'hui, nous demandons simplement que cette reconnaissance se traduise enfin dans les faits. Nous voulons que notre situation soit régularisée.

Propos recueillis par Gaëlle Cathala pour Debout 31 !

